

คู่มือการใช้งาน Claude AI Plugin ipd-nursing-ai-toolkit

ผู้ช่วย AI สำหรับทีมพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อสรุปรายงาน ทำสื่อนำเสนอ วางแผนการพยาบาล ตรวจสอบเวช
ระเบียน และสร้างเครื่องมือดิจิทัลของหน่วยงาน — มีด้าน PDPA และความปลอดภัยทางคลินิกในตัวทุกสเกล

สาขางาน: ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD-NSD) — ใช้ได้ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงานภายใต้สาขางาน

สำหรับ: ผู้บริหารการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน พยาบาลวิชาชีพ เลขานุการ และทีมข้อมูล

ฉบับที่ 1.0 | กันยายน 2569 (September 2026) | ภาษาไทย

หน้าลิขสิทธิ์

โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani International Hospital)

1 ซอยลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | โทร. (+66) 85-223-8888 |
www.vejthani.com

© 2569 โรงพยาบาลเวชธานี สงวนลิขสิทธิ์ เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมภายใน ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ภายนอก
โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารเลขที่: [IPD-NSD-AI-001] | ฉบับที่: 1.0 | วันที่มีผล: [กรอกวันที่อนุมัติ]

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานเครื่องมือ AI (Claude) ภายในโรงพยาบาลเวชธานีเท่านั้น
เนื้อหาที่ AI ผลิตออกมาผ่านสกรีนปพลิเคชันนี้เป็น "ร่าง" เพื่อการทบทวนเสมอ ไม่ใช่คำสั่งการรักษา ไม่ใช่
ดุลยพินิจทางคลินิกขั้นสุดท้าย และไม่แทนการตัดสินใจของแพทย์เจ้าของไข้ เภสัชกร หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ตัวเลข เป้าหมาย และนโยบายที่ AI ผลิตออกมาจะถูกเว้นเป็นสัญลักษณ์ เช่น [HOSPITAL_POLICY] ให้ผู้ใช้
เติมเอง ทุกผลลัพธ์ต้องผ่านการตรวจทานโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ก่อนนำไปใช้จริงหรือเผยแพร่

หน้าอนุมัติ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
ผู้จัดทำ				
ผู้ทบทวนด้าน AI/IT				
ผู้ทบทวนคุณภาพ/PDPA				
ผู้อนุมัติ (ผู้บริหารสายการ พยาบาล)				

วันที่มีผลบังคับใช้: _____ วันที่ทบทวนครั้งถัดไป: _____ (ทบทวนทุก 2 ปี หรือเมื่อความ
สามารถของปลั๊กอิน/นโยบาย PDPA เปลี่ยนแปลง)

คำนำ

ปลั๊กอิน ipd-nursing-ai-toolkit เป็นชุดผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานประจำของทีมงานพยาบาลผู้ป่วยใน ตั้งแต่การสรุปตัวเลขจาก Excel การทำสื่อนำเสนอผู้บริหาร การผลิตสื่อสอน การเตรียมความรู้โรคซับซ้อน การตรวจเวชระเบียนหาความเสี่ยง ไปจนถึงการออกแบบเครื่องมือดิจิทัลเล็กๆ ให้หน่วยงาน เป้าหมายคือกินเวลาให้พยาบาลได้ทำงานดูแลผู้ป่วยมากขึ้น โดยที่ทุกสภามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ป่วย (PDPA) และขอบเขตความปลอดภัยทางคลินิกฝังอยู่ในตัว

คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้งานหน่วยงานที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน AI มาก่อน อ่านจบแล้วควรเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องถามพี่เลี้ยง หากมีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งตามช่องทางในหน้าติดต่อท้ายเล่ม

สารบัญ

1. มาตรฐานอ้างอิงที่ผูก
2. อภิธานศัพท์และตัวย่อ
3. ส่วนที่ 1 — ก่อนเริ่มใช้งาน
4. ส่วนที่ 2 — เลือกสกรีนให้ถูกกับงาน
5. ส่วนที่ 3 — คู่มือใช้งานรายสกรีน (6 สกรีน)
 - 3.1 excel-report-analyst — สรุปรายงาน Excel
 - 3.2 onepage-slide-builder — one page และสไลด์
 - 3.3 nursing-teaching-media-studio — สื่อการสอน
 - 3.4 complex-case-care-plan — ความรู้โรคและแผนการพยาบาล
 - 3.5 chart-review-risk-finder — ตรวจเวชระเบียนหาความเสี่ยง
 - 3.6 ward-webapp-builder — เว็บแอปหน่วยงาน / AI ใช้งานจริง
 - 3.7 สกรีนที่ยังไม่พร้อมใช้งานในชุดนี้
6. ส่วนที่ 4 — PDPA ภาคปฏิบัติ
7. ส่วนที่ 5 — คำถามที่พบบ่อย
8. ภาคผนวก ก — Quick Reference Card
9. ภาคผนวก ข — ข้อจำกัดที่ทราบของระบบ
10. ภาคผนวก ค — รายการที่ต้องตรวจสอบโดยมนุษย์
11. ภาคผนวก ง — Version Control
12. ภาคผนวก จ — หน้าติดต่อ

มาตรฐานอ้างอิงที่ผูก

คู่มือนี้เป็นเอกสารแนวทางการใช้เครื่องมือ (Tool Usage Guide) ไม่ใช่แนวปฏิบัติทางคลินิกที่อ้างอิงงานวิจัย แหล่งอำนาจหลักของเนื้อหาคือ (1) ข้อกำหนดจริงที่เขียนไว้ในสเกลแต่ละตัวของปลั๊กอิน และ (2) นโยบาย PDPA/มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล จึงไม่มีการอ้างอิง PubMed ในเล่มนี้ — ส่วนความรู้ทางคลินิกที่สเกล complex-case-care-plan และ nursing-teaching-media-studio ผลิตออกมานั้น สเกลจะค้นและอ้างอิงแหล่งของตัวเองแยกต่างหากทุกครั้งที่ใช้งานจริง

มาตรฐาน	ชื่อ/หมวด	สอดคล้องกับส่วนใด
JCI	SQE — Staff Qualifications & Education	ส่วนที่ 1-3 (การฝึกใช้เครื่องมือใหม่ให้บุคลากร)
JCI	PCI / ACC / PFE (ตามเนื้อหาที่สเกลผลิต)	ส่วนที่ 3.3, 3.4 (สื่อสอน, ความรู้โรค)
ไทย	HA / SIMPLE (สรพ.)	ทั้งเล่ม — เน้น Patient Safety และ Just Culture (ส่วนที่ 3.5)
ไทย	PDPA พ.ศ. 2562	ทั้งเล่ม — โดยเฉพาะส่วนที่ 4

อภิธานศัพท์และตัวย่อ

คำ/ตัวย่อ	ความหมาย
Plugin (ปลั๊กอิน)	ชุดสกริปต์ที่ติดตั้งเข้ากับ Claude ครั้งเดียว แล้วใช้งานได้หลายสกริปต์โดยไม่ต้องเรียกทีละตัว
Skill (สกิล)	ชุดคำสั่งเฉพาะงานหนึ่งชิ้นภายในปลั๊กอิน — Claude เลือกสกริปต์ที่ตรงงานให้อัตโนมัติ
Prompt	ข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์สั่งงาน AI
De-identification	การลบ/แทนที่ข้อมูลที่ระบุตัวผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ได้ ก่อนนำไปประมวลผลกับ AI
HN / AN	เลขประจำตัวผู้ป่วย (Hospital/Admission Number) — ห้ามส่งให้ AI เด็ดขาด
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
CPG	Clinical Practice Guideline — แนวทางปฏิบัติทางคลินิกของโรงพยาบาล
Just Culture	วัฒนธรรมความปลอดภัยที่เน้นแก้ระบบ ไม่กล่าวโทษบุคคล
Token	หน่วยประมวลผลข้อความของ AI — ยิ่งข้อความยาว ยิ่งใช้ token มาก
Vibe coding	การสั่งให้ AI เขียนโปรแกรมให้จากคำอธิบายภาษาปกติ โดยผู้สั่งไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
Human Review Required	เครื่องหมายกำกับว่าเนื้อหาส่วนนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีอำนาจตรวจยืนยันก่อนใช้จริง

ส่วนที่ 1 — ก่อนเริ่มใช้งาน

1.1 ปลั๊กอินคืออะไร

ipd-nursing-ai-toolkit คือชุดสกริปต์ AI 6 ตัว (ในเวอร์ชันปัจจุบันของเอกสารชุดนี้) ที่สอน Claude ให้ทำงานแบบที่ทีมการพยาบาลผู้ป่วยในต้องการจริงในหน่วยงาน เมื่อติดตั้งในบัญชี Claude ของหน่วยงานแล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องจำชื่อสกริปต์หรือพิมพ์คำสั่งพิเศษ เพียงพิมพ์สิ่งที่อยากให้ช่วยเป็นภาษาไทยตามปกติ Claude จะอ่านคำขอแล้วเลือกสกริปต์ที่ตรงงานให้เอง

i หลักการสำคัญ

ทุกสกริปต์มี "ด้านความเป็นส่วนตัวผู้ป่วย (PDPA)" และ "ขอบเขตความปลอดภัยทางคลินิก" ฝังอยู่ในคำสั่งของสกริปต์เอง แต่ด้านเหล่านี้ทำงานผ่านการอ่านคำสั่ง ไม่ใช่ตัวกรองทางเทคนิคที่บังคับได้ 100% (ยกเว้นสคริปต์ตรวจ Excel) การอบรมและวินัยของผู้ใช้จึงยังเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุด

1.2 กฎเหล็ก 5 ข้อ ก่อนใช้ทุกครั้ง

⚠ ต้องอ่านก่อนใช้งานครั้งแรก

ห้ามส่งข้อมูลที่ระบุตัวผู้ป่วยได้ — HN, AN, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, เบอร์โทร, ที่อยู่, รูปถ่าย, ภาพหน้าจอ HIS ให้ใช้ 'ผู้ป่วย A' แทนชื่อ ช่วงอายุแทนอายุจริง และ Day 1/Day 2 แทนวันที่

AI ไม่วินิจฉัยโรค ไม่สั่งยา ไม่ให้ขนาดยา — ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเสมอ

แผนการพยาบาลและสื่อการสอนเป็น "ร่าง" — ต้องตรวจกับ CPG ของโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้จริง ตัวเลข เป้าหมาย และนโยบายที่ไม่มีข้อมูล Claude จะเว้นเป็นสัญลักษณ์ เช่น [KPI_TARGET] ให้ผู้ใช้เติมเอง จะไม่แต่งขึ้นมาเอง

ใช้เฉพาะเครื่องมือ AI ที่โรงพยาบาลอนุญาต และอ่านทวนผลงานทุกครั้งก่อนส่งต่อหรือเผยแพร่

1.3 วิธีเริ่มใช้งาน

- เปิดโปรแกรม/แอป Claude ที่หน่วยงานติดตั้งปลั๊กอินนี้ไว้แล้ว
- พิมพ์สิ่งที่ต้องการเป็นประโยคปกติ เช่น "ช่วยสรุปยอด admit เดือนนี้จากไฟล์นี้" — ไม่ต้องพิมพ์ชื่อสกริปต์
- ถ้าไม่ถนัด AI ให้พิมพ์บอกตรงๆ เช่น "ไม่ค่อยถนัด ช่วยถามทีละข้อ"
- ตรวจสอบผลลัพธ์ทุกครั้ง โดยเฉพาะตัวเลขและข้อมูลทางคลินิก ก่อนนำไปใช้หรือส่งต่อ
- ถ้าผลยังไม่ตรงใจ บอกสิ่งที่อยากแก้ตรงๆ เช่น "สั้นลงครึ่งหนึ่ง" "ภาษาง่ายกว่านี้"

ส่วนที่ 2 — เลือกสกิลให้ถูกกับงาน

ตารางนี้ช่วยให้เลือกใช้ได้เร็ว แต่ในทางปฏิบัติไม่จำเป็นต้องจำ เพราะ Claude เลือกสกิลที่ตรงงานให้อัตโนมัติจากคำขอภาษาไทยปกติ

อยากทำอะไร	สกิล	ได้อะไร
สรุปยอดผู้ป่วย census, admit, IV Team, KPI จาก Excel · รวมหลายไฟล์ · ยอดไม่ตรง	excel-report-analyst	สรุปภาษาไทย ตาราง จุดที่ข้อมูลซ้ำ/หาย วิธีคำนวณ กราฟที่แนะนำ
ทำ one page · สไลด์นำเสนอ · prompt ไปวางใน Gamma/NotebookLM	onepage-slide-builder	one page สถานการณ์→สิ่งที่พบ→ข้อเสนอ, โครงสไลด์, prompt พร้อมวาง
ทำคลิปสอน การดูแลความรู้ สื่อปฐมนิเทศ สื่อสอนญาติ	nursing-teaching-media-studio	วัตถุดิบประสมค์ โครงเนื้อหา สคริปต์ storyboard prompt Veo 3/Kling
ความรู้โรคที่ไม่คุ้น · แผนการพยาบาล · case conference	complex-case-care-plan	สรุปโรค สัญญาณอันตราย แผนการพยาบาล แหล่งอ้างอิง
open chart review · ตรวจเวชระเบียน · แจ้งทีมเรื่องความเสี่ยง	chart-review-risk-finder	รายการความเสี่ยงพร้อมระดับ ข้อความแจ้งทีมแบบไม่กล่าวโทษ
อยากได้เว็บ/แอปเล็กๆ ให้หน่วยงาน · ทีมข้อมูลอยากใช้ AI จริง/ลด token	ward-webapp-builder	spec หน้าเดียว prompt ส่ง Claude Code/Gemini + checklist ความพร้อม
 งาน IT ไม่ได้อยู่ในปลั๊กอินนี้ งานด้าน IT เช่น เอกสาร URS/UAT, เขียน SQL, แก้งบั๊กโค้ด, TRC แจ้ง vendor ให้ใช้ปลั๊กอิน hospital-it-ai-toolkit ที่มีอยู่แล้วแยกต่างหาก		

2.1 ใครควรใช้สกิลไหน (สรุปตามกลุ่มบทบาท)

สรุปจากการสำรวจความต้องการจริงของบุคลากร 13 กลุ่มบทบาท (รหัสเท่านั้น เพื่อความเป็นส่วนตัวของบุคลากร) — ทุกกลุ่มบทบาทมีสกิลหลักรองรับอย่างน้อย 1 ตัว ไม่มีกลุ่มใดที่ไม่ถูกครอบคลุม (รายละเอียดแบบเต็มพร้อมรหัส P1-P13 อยู่ในเอกสารภายในของผู้จัดอบรม)

ส่วนที่ 3 — คู่มือใช้งานรายสัปดาห์

แต่ละสัปดาห์มีโครงสร้างเดียวกัน: วัตถุประสงค์ → ใช้เมื่อไหร่/ไม่ควรใช้เมื่อไหร่ → ด้าน PDPA และความปลอดภัย → ขั้นตอนโดยย่อ → ตัวอย่างคำสั่ง → checklist ก่อนส่งงานต่อ

3.1 excel-report-analyst — สรุปรายงาน Excel แบบตัวเลขแม่นยำ

วัตถุประสงค์

ช่วยผู้บริหารการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน และเลขานุการ สรุปรายงานประจำวัน/ประจำเดือนจาก Excel (census, ยอด admit/discharge, IV Team, KPI, ข้อมูลคุณภาพ) ให้ถูกต้องและตรวจสอบได้ กฎเหล็ก: ไม่ประมาณ ไม่เดา ไม่คิดเลขในหัว — ตัวเลขทุกตัวมาจากผลรันโค้ดจริงและผ่านการกระทบยอดก่อนส่งคำตอบ

⚠ ด้าน PDPA (ทำก่อนทุกครั้ง)

ไฟล์ต้องไม่มี HN, AN, ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, เบอร์โทร, ที่อยู่ หรือรูปภาพ สกิลนี้มีสคริปต์ตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนด้วยโค้ดจริงก่อนคำนวณ ถ้าพบ Claude จะหยุดทันทีและขอไฟล์ที่ลบคอลัมน์นั้นจากต้นทางแล้วส่งใหม่ — Claude จะไม่ลบคอลัมน์ให้เองแล้วคำนวณต่อ

ขั้นตอนโดยย่อ

(1) บอกประเภทรายงาน ช่วงเวลา คอลัมน์ที่ต้องสรุป และยอดควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2) Claude สืบหาไฟล์ด้วยโค้ดก่อนคำนวณ แจ้งจำนวนแถว คอลัมน์ แถวซ้ำ/ค่าว่างให้เห็น (3) คำนวณและกระทบยอดกับต้นทาง (4) สรุปเป็นภาษาไทย พร้อมตารางและกราฟที่แนะนำ

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "ช่วยสรุปยอดผู้ป่วย admit เดือนนี้จากไฟล์ Excel นี้ แยกตามวอร์ด และเช็คว่ามีแถวซ้ำไหม"
- "รวมข้อมูล IV Team จาก 3 ไฟล์นี้เป็นสรุปรายเดือนไฟล์เดียว แล้วบอกว่ายอดตรงกับต้นฉบับไหม"
- "ยอดที่ฉันรวมเองไม่ตรงกับยอดในระบบ ช่วยหาว่าผิดตรงไหน ฉันไม่ค่อยถนัด Excel ช่วยอธิบายง่ายๆ นะ"

✅ ก่อนแนบไฟล์ / ก่อนส่งต่อผลลัพธ์

ลบคอลัมน์ HN ชื่อ เลขบัตร วันเกิด ออกจากไฟล์ต้นทางก่อนแนบ เหลือเฉพาะคอลัมน์ที่ใช้คำนวณ ตรวจสอบตัวเลขสรุปกับต้นฉบับอีกครั้งด้วยตนเอง แม้ Claude จะกระทบยอดให้แล้ว

3.2 onepage-slide-builder — one page และสไลด์แบบผู้บริหารอ่านแล้วตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์

เปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (ตัวเลขที่สรุปแล้ว บันทึกงาน ผลประชุม) ให้เป็นงานนำเสนอที่ชัด สั้น มีข้อเสนอได้ 4 รูปแบบ: (A) one page brief (B) โครงสไลด์ (C) prompt สำหรับ Gamma (D) ชุดเตรียมข้อมูล + prompt สำหรับ NotebookLM

⚠️ ด้าน PDPA

งานนำเสนอใช้ข้อมูลรวมเท่านั้น ห้ามมี HN, AN, ชื่อผู้ป่วย เลขบัตร วันเกิด หรือรูปผู้ป่วย
ชื่อเจ้าหน้าที่ในเอกสารเสี่ยงให้ใช้บทบาทแทน เช่น 'RN เวิร์กเชา'

🔗 ถ้ามีไฟล์ Excel ดิบ

ให้ใช้สกิล excel-report-analyst คำนวณตัวเลขให้ถูกต้องก่อน แล้วค่อยนำผลสรุปมาทำ one page/สไลด์ต่อ — สกิลนี้จะไม่คิดเลขเองจากไฟล์ดิบ

ขั้นตอนโดยย่อ

(1) บอกผู้ฟัง เป้าหมาย (แจ้งให้ทราบ/ขออนุมัติ/ขอทรัพยากร) รูปแบบ และความยาว (2) Claude หา "ข้อความหลัก" หนึ่งประโยค: "[สิ่งที่พบ] ดังนั้น [สิ่งที่เสนอ/ขอ]" (3) จัดลำดับเรื่อง สถานการณ์→สิ่งที่พบ→สิ่งที่ต้องทำ (4) สร้างผลลัพธ์ตามรูปแบบที่เลือก

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "ทำ one page เสนอผู้อำนวยการฝ่าย เรื่องผลตัวชี้วัดไตรมาสนี้ ตัวเลขตามที่แนบ"
- "เขียน prompt ไปวางใน Gamma ทำสไลด์ 8 หน้า นำเสนอขอบเขตงานหอผู้ป่วยใน"
- "เรียบเรียงบันทึกนี้เป็นสไลด์ขอเพิ่มอัตราค่าจ้าง นำเสนอ 10 นาที"

✅ ก่อนนำเสนอจริง

ตรวจว่ามี "ข้อความหลัก" ที่ผู้ฟังต้องจำชัดเจน 1 ประโยค ไม่ใช่แค่รายงานตัวเลข
ตรวจว่าไม่มีตัวระบุตัวผู้ป่วยหรือชื่อเจ้าหน้าที่หลุดเข้าไปในสไลด์

3.3 nursing-teaching-media-studio — สตูดิโอสื่อการสอนทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและพยาบาลผู้สอนสร้างสื่อการสอนที่ถูกต้องทางวิชาการ เข้าใจง่าย และผลิตต่อได้ทันทีด้วยเครื่องมือที่ทีมใช้อยู่ (Veو 3, Kling, Gemini, Gamma, NotebookLM, โปรแกรมตัดต่อ) ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ โครงเนื้อหา สคริปต์ storyboard prompt ภาพ/วิดีโอ ไปจนถึงคำถามท้ายบท

⚠️ ด้าน PDPA และความปลอดภัยทางคลินิก

กรณีศึกษาในสื่อต้องเป็นเคสสมมติเท่านั้น ถ้าดัดแปลงจากเคสจริงต้องลบ HN, AN, ชื่อ เลขบัตร วันเกิด วันที่ จนระบุตัวไม่ได้ ห้ามใช้ภาพผู้ป่วยหรือภาพหน้าจอ HIS

เนื้อหาความรู้ทุกชิ้นต้องมีแหล่งอ้างอิงและติดป้าย "ต้องทบทวนกับ CPG โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญก่อนเผยแพร่" ห้ามใส่ขนาดยา อัตราหยดยา หรือคำสั่งการรักษา

ขั้นตอนโดยย่อ

(1) บอกหัวข้อ ผู้เรียน รูปแบบสื่อ ความยาว แหล่งเนื้อหา และบริบทการใช้สอน (2) กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3-5 ข้อ ปรับระดับตามผู้เรียน (3) ทำโครงเนื้อหาพร้อมแหล่งอ้างอิงและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (4) เขียนสคริปต์/storyboard และ prompt สำหรับเครื่องมือผลิตสื่อ

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "ทำสคริปต์คลิปสอนพยาบาลใหม่เรื่องป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม 2 นาที พร้อม prompt Veو 3"
- "ออกแบบการ์ตูนอธิบายการดูแลสายสวนปัสสาวะที่บ้าน ให้ญาติผู้ป่วยสูงอายุเข้าใจง่าย"
- "ทำ storyboard วิดีโอปฐมพยาบาลใหม่ของหอผู้ป่วย แล้วจะเอาไปทำใน Kling"

✅ ก่อนเผยแพร่สื่อ

ให้ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของ CPG ตรวจสอบเนื้อหาความรู้และป้าย "ต้องทบทวน" ก่อนใช้สอนจริง
ยืนยันว่าเคสในสื่อเป็นเคสสมมติ 100% ไม่มีร่องรอยที่สืบทกลับไปหาผู้ป่วยจริงได้

3.4 complex-case-care-plan — ความรู้โรคซับซ้อนและแผนการพยาบาลที่อ้างอิงได้

วัตถุประสงค์

ช่วยเตรียมความรู้และแผนการพยาบาล (nursing care plan) สำหรับโรคหรือภาวะที่ทีมยังไม่คุ้นเคย เพื่อให้สอนและเป็นแนวทางเริ่มต้นให้พยาบาลในหอผู้ป่วย ผลลัพธ์เป็นร่างเพื่อทบทวน ไม่ใช่คำสั่งการรักษา

⚠️ **ด้าน PDPA (บังคับก่อนทำอย่างอื่น)**

ห้ามส่ง HN, AN, ชื่อผู้ป่วยหรือญาติ, เลขบัตร, วันเกิด, เบอร์โทร, ที่อยู่, รูปถ่าย/ภาพหน้าจอ ให้ใช้ "ผู้ป่วย A" ช่วงอายุ และเวลาสัมพัทธ์ (Day 1, POD 1) แทน

หากพบตัวระบุตัวตนแม้เพียงรายการเดียว — แม้ผู้ใช้จะบอกว่าเป็นข้อมูลสมมติแต่รูปแบบเหมือนจริง — Claude จะหยุดทันที ไม่สรุปโรค ไม่ทำแผน คำถามความรู้ทั่วไปที่ไม่มีข้อมูลผู้ป่วยทำต่อได้ทันที

🚫 **ขอบเขตที่สภานี้ไม่ทำ**

ไม่วินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยรายใด ไม่สั่งยา/ขนาดยา/ปรับยา ไม่เปลี่ยนคำสั่งการรักษา ไม่ตัดสินใจแทนแพทย์ หากข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ป่วยอาจกำลังทรุดลง สภานี้จะแนะนำให้ประเมินและรายงานแพทย์ทันทีตามนโยบาย Early Warning ของโรงพยาบาลก่อนทำแผนใดๆ

ขั้นตอนโดยย่อ

(1) ระบุโรค/ภาวะและบริบท (หอผู้ป่วยทั่วไป/ICU/หลังผ่าตัด) และผู้ใช้ผลงาน (2) Claude หาแหล่งอ้างอิงตามลำดับความน่าเชื่อถือ (3) สรุปความรู้โรคและ/หรือทำแผนการพยาบาลพร้อมข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล เป้าหมาย กิจกรรม และการเฝ้าระวัง

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "ขอความรู้โรค Guillain-Barré syndrome และแผนการพยาบาลสำหรับพยาบาลในวอร์ด พร้อมแหล่งอ้างอิง"
- "ผู้ป่วย A หญิง 40-49 ปี เป็น Stevens-Johnson syndrome พยาบาลไม่เคยดูแล ช่วยทำ nursing care plan"
- "เตรียมความรู้และข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลสำหรับ case conference ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี delirium"

✅ **ก่อนนำไปใช้**

ให้แพทย์เจ้าของไข้และ/หรือเภสัชกรทบทวนส่วนที่เกี่ยวกับยาและการรักษาก่อนนำไปปฏิบัติ

ตรวจสอบกับ CPG ของโรงพยาบาลว่าสอดคล้องกันหรือไม่ หากขัดแย้งให้ยึด CPG ของโรงพยาบาลเป็นหลัก

3.5 chart-review-risk-finder — ตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ หาความเสี่ยง และสื่อสารทีม

วัตถุประสงค์

ช่วยทำ open chart review / ตรวจเวชระเบียนได้เร็วและเป็นระบบ หาจุดเสี่ยงจากบันทึก จัดระดับความรุนแรง เสนอแนวทางลดความเสี่ยง และร่างข้อความสื่อสารทีมแบบไม่กล่าวโทษบุคคล (Just Culture) ผลลัพธ์เป็นข้อสังเกตให้ทีมทบทวน ไม่ใช่การตัดสินทางคลินิกหรือทางวินัย

⚠️ ด้าน PDPA (บังคับก่อนอ่านเนื้อหาบันทึกใดๆ)

รับเฉพาะข้อความบันทึกที่ลบตัวระบุตัวตนแล้วเท่านั้น ห้ามมี HN, AN, ชื่อผู้ป่วยหรือญาติ, เลขบัตร, วันเกิด, เบอร์โทร, ที่อยู่, ภาพหน้าจอ HIS/รูปภาพใดๆ วันที่จริงให้เปลี่ยนเป็น Day/เวรสัมพันธ์ ชื่อเจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนเป็นบทบาท

หากพบตัวระบุแม้รายการเดียว หรือได้รับเป็นภาพ — Claude จะหยุดทันที ไม่ตรวจ ไม่สรุป ไม่ร่างข้อความใดๆ

🚨 หากบันทึกบ่งชี้ว่าผู้ป่วยกำลังทรุดลง (เคสปัจจุบัน)

สกลีจะขึ้นต้นคำตอบด้วยคำแนะนำให้พยาบาลผู้ดูแลประเมินและรายงานแพทย์ทันทีตามนโยบาย Early Warning ของโรงพยาบาล ก่อนรอผลการทำ audit ใดๆ — สกลีนี้ไม่วินิจฉัยและไม่สั่งการรักษา

ขั้นตอนโดยย่อ

(1) ระบุประเภท (open chart review ผู้ป่วยยังอยู่ / retrospective audit ผู้ป่วยจำหน่ายแล้ว) และจุดเน้น เช่น พัสดตกหล่น แผลกดทับ การบริหารยา ความปวด (2) Claude รันรายการตรวจตามหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้ผลเป็น "พบ/ไม่พบ/ข้อมูลไม่พอประเมิน" พร้อมหลักฐานจากบันทึก (3) จัดระดับความเสี่ยงและร่างข้อความแจ้งทีมแบบไม่กล่าวโทษ

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "ช่วย open chart review บันทึกนี้ (ลบข้อมูลระบุตัวตนแล้ว) เน้นพัสดตกหล่นและความปวด"
- "จากบันทึก 3 เวนี่ มีจุดไหนบันทึกไม่ครบ แล้วร่างข้อความ LINE แจ้งทีมแบบไม่กล่าวโทษ"
- "ตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยที่จำหน่ายแล้ว เน้นการประเมินความปวดซ้ำหลังให้ยา"

✅ ก่อนส่งผลตรวจให้ทีม/คณะกรรมการคุณภาพ

ยืนยันว่าไม่มีตัวระบุตัวผู้ป่วยหรือชื่อเจ้าหน้าที่หลงเหลืออยู่ในผลลัพธ์ก่อนส่งต่อ

ตรวจว่าน่าเสี่ยงเป็นแบบไม่กล่าวโทษบุคคล สอดคล้องกับหลัก Just Culture ของโรงพยาบาล

3.6 ward-webapp-builder — เว็บแอปหน่วยงาน / AI ใช้งานจริง

วัตถุประสงค์

สองแตร็กในสเกลเดียว — แตร็กหน่วยงาน (Ward) สำหรับพยาบาล/เลขานุการที่ไม่ใช่ักพัฒนา (ปัญหา → spec หน้าเดียว → prompt พร้อมวางใน Claude Code/Gemini) และแตร็กทีมข้อมูล (Builder) สำหรับนักวิทยาศาสตร์/วิศวกรข้อมูล (หา use case, ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้จริง, ลด token ของระบบ agent) สเกลนี้ไม่ทำเอกสาร URS/UAT ไม่รีวิวโค้ด และไม่เขียนแอปทั้งตัวในแชท — ผลลัพธ์คือ spec และ prompt ที่นำไปสร้างต่อ

⚠ PDPA by design

ต้นแบบ (prototype) ใช้ข้อมูลสมมติเท่านั้น ห้ามวางข้อมูลผู้ป่วยจริงลงในเครื่องมือ AI ระหว่างสร้าง ออกแบบให้แอปเก็บข้อมูลรวมหรือรหัสสมมติ หลีกเลี่ยงฟิลด์ HN ชื่อ เลขบัตร วันเกิด

หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริง ต้องผ่านกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลของฝ่าย IT ก่อนเสมอ ห้ามใส่ API key รหัสผ่าน หรือ URL ระบบภายในลงใน spec/prompt โดยตรง

ขั้นตอนโดยย่อ

วิธีเลือกแตร็ก: คำขอพูดถึง API, deploy, production, agent, token, RAG, model หรือผู้ใช้บอกว่า เป็นทีมพัฒนา/ข้อมูล → แตร็ก Builder นอกนั้น → แตร็ก Ward ถ้าไม่ชัด สเกลจะถามหนึ่งคำถาม: "จะสร้างเองด้วย AI แบบไม่เขียนโค้ด หรือทีมพัฒนาจะนำไปสร้างต่อ"

ตัวอย่างคำสั่ง (คัดลอกไปปรับใช้ได้)

- "อยากทำเว็บให้เลขาوردกรอกยอดผู้ป่วยรายวันแล้วออกรายรายเดือน ช่วยคิด spec ให้หน่อย" (แตร็ก Ward)
- "เขียน prompt ส่ง Claude Code สร้างแอป checklist ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน แบบประหยัด token" (แตร็ก Ward)
- "ระบบ agentic AI ของเราแบ่ง role 4 ตัว กิน token เยอะ มีเทคนิคลดไหม" (แตร็ก Builder)

✅ ก่อนนำไปใช้งานจริง (Production)

ผ่าน checklist ความพร้อมก่อนใช้งานจริง (production readiness) ในสเกลนี้ครบทุกข้อ ยืนยันกับฝ่าย IT ว่าฟิลด์ข้อมูลที่ออกแบบไม่ละเมิด PDPA และมีเจ้าของระบบที่ชัดเจน

3.7 สกิลที่ยังไม่พร้อมใช้งานในชุดนี้

◆ Human Review Required — ความไม่ครบถ้วนของชุดไฟล์

เอกสารประกอบของปลั๊กอิน (README และตาราง role coverage) กล่าวถึงสกิลเพิ่มเติมอีก 2 ตัว คือ nursing-exam-builder (ออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/วิเคราะห์ผลสอบ) และ nurse-leader-secretary (จัดลำดับงานรายวัน สรุปประชุม ติดตามเอกสาร ร่างบันทึกข้อความ)

ในชุดไฟล์ที่ใช้จัดทำคู่มือฉบับนี้ ยังไม่มีไฟล์ SKILL.md ของสกิลทั้งสองตัว จึงยังไม่สามารถใช้งานได้จริงและไม่ได้รวมรายละเอียดไว้ในคู่มือนี้ เพื่อป้องกันการเขียนขั้นตอนที่ไม่ตรงกับของจริง กรุณาให้ผู้ดูแลปลั๊กอินยืนยันและแนบไฟล์ทั้งสองก่อนออกคู่มือฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 4 — PDPA ภาคปฏิบัติ

4.1 ข้อมูลที่ห้ามส่งให้ AI เด็ดขาด

- HN, AN (เลขประจำตัวผู้ป่วย/การรับเข้า)
- ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วยหรือญาติ
- เลขบัตรประชาชน, วันเกิดจริง, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่
- รูปถ่ายผู้ป่วย หรือภาพหน้าจอระบบ HIS ทุกชนิด

4.2 วิธี De-identify ก่อนใช้งาน

ข้อมูลจริง	ให้แทนที่ด้วย
ชื่อผู้ป่วย	"ผู้ป่วย A", "ผู้ป่วย B"
อายุจริง	ช่วงอายุ 10 ปี เช่น "60-69 ปี"
วันที่จริง	วันสัมพัทธ์ เช่น "Day 1", "Day 2", "POD 1"
ชื่อเจ้าหน้าที่	บทบาทและเวอร์ เช่น "RN เวอร์เข้า", "หัวหน้าเวรดึก"

4.3 ถ้า Claude แจ้งว่าพบข้อมูลระบุตัวตน

Claude จะหยุดทำงานทันที บอกเฉพาะประเภทของข้อมูลที่พบ (เช่น "พบ HN และชื่อผู้ป่วย") โดยไม่คัดลอกค่าจริงซ้ำในคำตอบ และรอให้ผู้ส่งฉบับที่แก้ไขแล้วกลับมา ผู้ใช้ต้องเป็นคนลบข้อมูลจากต้นทางเอง Claude จะไม่ลบให้แล้วทำงานต่อ นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของระบบ แต่เป็นด้านความปลอดภัยที่ทำงานตามที่ออกแบบไว้

ส่วนที่ 5 — คำถามที่พบบ่อย

ต้องพิมพ์ชื่อสกิลก่อนไหม?

ไม่ต้อง พิมพ์สิ่งที่ยากได้เป็นภาษาไทยปกติ Claude จะเลือกสกิลที่ตรงงานให้เอง

ไม่ล้น AI เลย เริ่มยังไงดี?

พิมพ์บอกตรงๆ ว่า "ไม่ค่อยล้น ช่วยถามทีละข้อ" ทุกสกิลมีโหมดย่อยสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะถามทีละคำถามด้วยภาษาง่ายๆ

ผลลัพธ์ยังไม่ตรงใจ แก้งาน?

บอกสิ่งที่ยากแก่ตรงๆ เช่น "สั้นลงครึ่งหนึ่ง" "ภาษาง่ายกว่านี้" "เปลี่ยนผู้ฟังเป็นทีมในบอร์ดแทนผู้บริหาร"

ตัวเลขที่ Claude คำนวณเชื่อได้แค่ไหน?

สกิล excel-report-analyst คำนวณด้วยโค้ดจริงและกระตือรือร้นให้เสมอ แต่ควรตรวจกับต้นฉบับอีกครั้งทุกครั้งก่อนใช้งานจริง ตามหลักการ "Human Review Required" ของคู่มือนี้

ถ้าอยากได้ use case ใหม่ที่ยังไม่มีในตารางส่วนที่ 2 ทำอย่างไร?

ลองพิมพ์สิ่งที่ยากได้ตามปกติก่อน สกิลหลายตัวครอบคลุมกว้างกว่าตัวอย่างในคู่มือ หากยังไม่มีสกิลรองรับจริงๆ ให้แจ้งผู้ดูแลเปลี่ยนตามช่องทางในภาคผนวก จ เพื่อพิจารณาพัฒนาสกิลใหม่

ภาคผนวก ก — Quick Reference Card (พิมพ์แยกติดหน้างานได้)

ก่อนใช้ทุกครั้ง: ห้ามส่ง HN/AN/ชื่อ/เลขบัตร/วันเกิด/เบอร์โทร/ที่อยู่/รูปภาพผู้ป่วย · AI ไม่วินิจฉัย ไม่สั่งยา · ผลลัพธ์ทุกชิ้นเป็น "ร่าง" ต้องตรวจสอบก่อนใช้จริง

งาน	พูดกับ Claude ว่า...
สรุปยอด/Excel	"สรุปยอด [ระบุ] จากไฟล์นี้ แยกตาม [หน่วย]"
one page/สไลด์	"ทำ one page เสนอ [ใคร] เรื่อง [อะไร]"
สื่อสอน	"ทำ [คลิป/การ์ตูน] สอนเรื่อง [หัวข้อ] ให้ [ผู้เรียน]"
ความรู้โรค/care plan	"ขอความรู้โรค [ชื่อโรค] และแผนการพยาบาล"
ตรวจเวชระเบียน	"ช่วย chart review บันทึกรุ่นนี้ (ลบข้อมูลระบุตัวตนแล้ว) เน้น [ประเด็น]"
เว็บแอปหน่วยงาน	"อยากทำเว็บให้ [ใคร] ทำ [อะไร] ช่วยคิด spec ให้หน่อย"

ภาคผนวก ข — ข้อจำกัดที่ทราบของระบบ

- ผลการเลือกสก็ลอัตโนมัติของ Claude ยังไม่ได้ทดสอบครบในสภาพใช้งานจริงทุกกรณี — มีเฉพาะการตรวจสอบเบื้องต้น (desk-check)
- ด้าน PDPA ของสก็ลสนทนาส่วนใหญ่ทำงานผ่านคำสั่งที่เขียนไว้ ไม่ใช่ตัวกรองทางเทคนิคที่บังคับได้ 100% มีเพียงสคริปต์ของสก็ล excel-report-analyst ที่ตรวจด้วยโค้ดจริง — การอบรมผู้ใช้จึงยังสำคัญที่สุด
- สคริปต์ตรวจ Excel ยังไม่รองรับ merged cells, หัวตารางหลายชั้น และการแปลงปี พ.ศ. อัตโนมัติ
- ความสามารถของเครื่องมือภายนอก (Gamma, NotebookLM, Veo 3, Kling, Claude Code) เปลี่ยนแปลงบ่อย ควรตรวจเมนูและข้อจำกัดล่าสุดของแต่ละเครื่องมือเอง
- placeholder เช่น [HOSPITAL_CPG] [STAFFING_POLICY] [HOSPITAL_EARLY_WARNING_POLICY] ต้องให้หน่วยงานเจ้าของนโยบายเติมหรือชี้เอกสารจริงก่อนนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติจริง
- สกิล nursing-exam-builder และ nurse-leader-secretary ที่ระบุในเอกสารประกอบยังไม่มีไฟล์ใช้งานจริงในชุดนี้ (ดูส่วนที่ 3.7)

ภาคผนวก ค — รายการที่ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันก่อนนำเอกสารนี้ไปใช้จริง

#	หัวข้อ/ส่วน	รายการที่ต้องยืนยัน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	ส่วนที่ 3.7	ยืนยันสถานะและแนบไฟล์ SKILL.md ของสเกลที่ขาด หรือถอดออกจากแผนใช้งานอย่างเป็นทางการ	ผู้ดูแลปลั๊กอิน	☐
2	หน้ามาตรฐานอ้างอิง	ยืนยันหมายเลขข้อ JCI ที่ถูกต้องตามฉบับปัจจุบัน	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	☐
3	ส่วนที่ 4	ตรวจสอบวิธี de-identify ให้สอดคล้องกับนโยบาย PDPA ล่าสุด	DPO/ฝ่ายกฎหมาย	☐
4	หน้าอนุมัติ	ลงนามอนุมัติให้เอกสารมีผลบังคับใช้จริง	ผู้บริหารสายการพยาบาล	☐

เอกสารนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ จนกว่าทุกรายการข้างต้นจะได้รับการยืนยันครบถ้วน

ภาคผนวก ง — Version Control

ฉบับที่	วันที่	ผู้แก้ไข	สาระสำคัญที่แก้ไข	ผู้อนุมัติ
1.0	กันยายน 2569		ฉบับแรก — ครอบคลุม 6 สกิลที่มีไฟล์จริงในชุด ipd-nursing-ai-toolkit	

ภาคผนวก จ — หน้าติดต่อ

หน่วยงานเจ้าของเอกสาร: [ระบุชื่อหน่วยงาน/ผู้จัดทำ]

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานหรือข้อผิดพลาดของคู่มือ: [ระบุอีเมล/LINE OA/ช่องทางภายใน]

ผู้ดูแลปลั๊กอินด้านเทคนิค: [ระบุทีมข้อมูล/IT ผู้รับผิดชอบ]

โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani International Hospital) · โทร. (+66) 85-223-8888 · www.vejthani.com